非典型的な形態を示し判断に苦慮した日本住血吸虫症の一例

◎川井 孝太[1)]、北村 文香[1)]、久米 彩也香[1)]、岩﨑 琢真[1)]、熊谷 慧人[1)]、上村 のり子[1)]、久留島 幸路[1)]
磐田市立総合病院[1)]

【はじめに】近年、静岡県だけでなく海外渡航の増加や在日外国人の増加、食生活の変貌などによる日本の国際化が進んでいる。今回、非典型的な形態を示し判断に苦慮した寄生虫感染症を経験し一般検査部門だけでなく多部門との連携により総合的に判断し診断に繋げることができた症例を経験したので報告する。
【症例】フィリピン国籍，40 代女性。四肢に内出血痕が多発し前医を受診。高度な腎機能低下を認め当院腎臓内科へ初回受診、末期腎不全に対して透析目的で入院となった。腎動脈エコーを施行したところ､肝実質にびまん性に線状･帯状の高エコーが網目状になっており日本住血吸虫症が疑われたため便中寄生虫卵検査や下部内視鏡検査が施行された。
【血液検査】WBC 7500/μL,RBC 277×104/μL,Hb 7.9g/dL,Ht 24.1%,Ret 4.15%,TP 6.2g/dL,ALB 3.5g/dL,BUN 75mg/dL,CRE 9.46mg/dL,UA 11.4mg/dL
【エコー検査】肝実質にはびまん性に線状･帯状の高エコーが網目になっており、日本住血吸虫症の典型例と類似している。
【寄生虫卵検査】虫卵様の形態を示すものが観察されたが日本住血吸虫卵に特徴的な突起がなく非典型的だったが多部門の結果も考慮し日本住血吸虫卵陽性疑いと判断し医師へ報告した。
【まとめ】日本住血吸虫卵に特徴的な突起物や虫卵内容物が非典型的な形態を示した症例を経験した。一般検査部門だけでなく多部門連携がとれた症例だった。
【考察】形態検査では、典型的な形態を示していないものも多い。寄生虫卵検査は陽性例などを見る機会が減少しており判断に苦慮することも多いように感じる。標本上の情報だけでなく多部門と連携し総合的に判断することで臨床へ付加価値の高い検査結果が報告できると思う。
磐田市立総合病院 0538-38-5000